

سيلترا هيلث — الوثيقة الطبية

أين تقف المنصة من الرعاية، ولمن، وبأي حدود

إصدار 0.1، مسودة عمل. سيلترا وان. موجهة للمستشارين الطبيين ومقدمي الرعاية.

0. حدّ نبدأ به

سيلترا هيلث تقنية تساعد الناس على فهم صحتهم اليومية ومتابعتها، وعلى الوصول إلى من يهتمهم أمرهم في الوقت المناسب. هي سند للرعاية بين الزيارات، لا بديل عنها. لا تشخص، ولا تسمي حالة، ولا تحدد جرعة، ولا تتنبأ بأزمة، ولا تحل محل الطبيب أو الصيدلي. اقرأ كل ما يلي داخل هذا الحدّ، فهو يحكم كل سطر.

1. أين تقف بالضبط

معظم عمر المريض يمرّ خارج العيادة. زيارة قصيرة كل بضعة أشهر، وبينها حياة كاملة من التفاصيل الصغيرة التي لا يراها أحد. ما تفعله سيلترا هيلث أنها تلتقط سياق هذه الأيام، حركة الشخص ونومه وبيئته بيتته والتزامه بدوائه، وتنظّمه في صورة هادئة تساعد على الفهم، وتساعد فريق الرعاية على حوار أوضح حين يأتي موعد الزيارة. القيمة هنا ليست في رقم جديد، بل في الاستمرارية. أن يبقى بين الزيارتين خيط متابعة لطيف، يطمئن حين تكون الأمور على ما يرام، ويلفت الانتباه بهدوء وبسبب واضح حين يتغيّر شيء يستحق أن يُسأل عنه.

2. من يستفيد، وما القيمة الطبية له

كبار السن. كثير منهم يقدّرون استقلالهم أكثر من أي شيء، وأسرههم تعيش بين الرغبة في الاطمئنان والخوف من التطفّل. المنصة تلاحظ تغيّرات النمط المعتاد، كغياب حركة اعتاد أن يحدث، فتساعد على الاطمئنان دون تحويل البيت إلى مساحة مراقبة. مع صراحة كاملة في الحدّ: هذه أداة دعم ومتابعة، ليست خدمة طوارئ، ولا تضمن وصول المساعدة، ويبقى الاتصال بالطوارئ أو مقدم الرعاية هو الإجراء الصحيح عند الحاجة الحقيقية [1][4].

الأمراض المزمنة. المريض المزمّن يعيش على قياسات ومواعيد وقرارات صغيرة متكررة. تنظيم القراءات على خط زمني، بجانب سياقه من نشاط ونوم، يجعل الاتجاه أوضح من الرقم المنفرد، ويجعل زيارة العيادة أكثر فائدة. لا يغيّر دواءه ولا جرعته، والقرار الطبي يبقى بينه وبين مقدم رعايته [8].

أصحاب الهمم. الوصول عندنا حق في صميم التصميم لا إضافة لاحقة. من يعيش مع إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو صعوبة في النطق أو حساسية حسية أو صعوبة في الذاكرة، يجد بيئة تفهم طريقته، وتعرض المعلومة بأكثر من قناة، وترك القرار كاملاً له. المبدأ استقلالية أكبر لا رقابة أكبر [7].

الصحة اليومية والرياضة. لمن يهتم بلياقته وتعافيه، ربط بيانات الجسم ببيئة المنزل يفسّر أنماطاً تخصّ النوم والتعافي، ويساعد على عادات أفضل، دون أي ادعاء علاجي.

3. كيف نقرأ التغيّر بطريقة مسؤولة

نبني لكل شخص خطأ أساسياً خاصاً به، ونقارنه بنفسه لا بمتوسط عام، لأن ما هو طبيعي لأحدهم قد يكون لافتاً لغيره. ولا نصدر أي تنبيه انحراف قبل فترة تعلّم تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة، ولا نعدّ التغيّر انحرافاً إلا حين تتوافق إشارتان مستقلتان على الأقل في الوقت نفسه. هذا الحرص مقصود، لأن الإنذار الكاذب المتكرر لا يزعم فقط، بل يفقد الثقة ويجعل الناس يتجاهلون حتى ما يهم [6]. وحين تغيب البيانات، نعاملها كعطل تقني نخبر به المستخدم، لا كإشارة صحية سلبية.

4. الالتزام الدوائي، من زاوية طبية

عدم الالتزام بالدواء مشكلة موثقة الأثر على النتائج والكلفة [2][3]. جزء منها ليس نقص الدواء، بل توقيت. تاريخ نفاذ العبوة معلومة محسوبة، لكن لا أحد يتصرّف بناءً عليها في وقتها. ما نقدّمه تذكير دقيق قبل النفاذ، يصل غالباً لمن يري المريض، فيرفع فرصة إعادة الصرف في وقتها. هذه قيمة سلوكية وتشغيلية، وليست تدخلاً دوائياً. لا نقرر متى يُصرف

الدواء، ولا نعدّل جرعة، والصيدلي يصرف وفق وصفة صالحة.

5. السلامة الطبية وحدود الاستخدام

نكزرها لأنها الأهم. المنصة لا تشخص ولا تعالج، ولا تتنبأ بأزمة، ولا تراقب طبيباً على مدار الساعة، ولا تتصل بالإسعاف تلقائياً. أي عرض مقلق أو تدهور مفاجئ ليس شأن المنصة، بل شأن طلب الرعاية الطبية فوراً. ونصمّ النصوص بحيث لا توهي بغير ذلك، ونراجعها قبل كل إطلاق حتى يبقى ما نقوله داخل نطاق العافية. وكل تنبيه نرسله له سبب نستطيع شرحه للمستخدم بجملة واحدة.

6. دور الطبيب ومقدم الرعاية

نرى بياناتنا سنداً لحوار الرعاية لا بديلاً عنه. تساعد المريض على أن يأتي إلى الزيارة بصورة مرتبة بدل أرقام متفرقة، وتساعد مقدم الرعاية على متابعة أدق بين الزيارات وفق ما يأذن به المريض. القرارات الحرجة والتصعيد تبقى داخل خطة يضبطها المستخدم، لا قرارات تلقائية عن الطوارئ. والإنسان يبقى في الحلقة دائماً.

7. ما نراقبه، ولماذا اخترناه

نبدأ بمؤشرات عامة ومفهومة، كالحركة والوجود والنوم والقراءات اليومية التي يأذن بها المستخدم، وإشارات بيئة المنزل كالحرارة والرطوبة وجودة الهواء التي ترتبط بالراحة والنوم [5]. نختار ما يخدم الفهم والمتابعة، لا ما نستطيع جمعه فقط. وكل مؤشر جديد ذي حساسية صحية نضيفه بمبرر واضح وموافقة مستقلة.

8. اعتبارات أخلاقية طبية

نصمّ حول كرامة الإنسان أولاً. الاستقلالية تعني أن يبقى صاحب البيانات صاحب القرار في من يرى ماذا ومتى. وعدم الإضرار يعني أن نتحفظ في الادعاء ونصرّح بالحدود بدل أن نبالغ. والعدالة تعني أن يكون الوصول حقاً لأصحاب الهمم لا امتيازاً. والخصوصية شرط لا رفاهية، فلا نشارك بيانات فردية مع أي جهة تسعّر خدمة أو تغطية.

9. المراجع

جميع المراجع أدناه حقيقية ومنشورة. راجع تفاصيلها الدقيقة وحديثها قبل أي نشر خارجي أو تحكيم.

1. World Health Organization. *World Report on Ageing and Health*. Geneva: WHO; 2015.
2. World Health Organization (Sabaté E, ed.). *Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action*. Geneva: WHO; 2003.
3. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. *New England Journal of Medicine*. 2005;353(5):487–497.
4. World Health Organization. *Falls* (fact sheet). Geneva: WHO.
5. World Health Organization. *Housing and Health Guidelines*. Geneva: WHO; 2018.
6. The Joint Commission. *Sentinel Event Alert 50: Medical Device Alarm Safety in Hospitals*. 2013.
7. World Wide Web Consortium (W3C). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. 2018.
8. World Health Organization. *Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases 2013–2020*. Geneva: WHO; 2013.
9. IMDRF SaMD Working Group. *Software as a Medical Device (SaMD): Key Definitions*. 2013.

10. أسئلة للمستشار الطبي

نطرحها مبكراً ونحسمها معه. ما المؤشرات الأنسب لكل فئة، وكيف نعاير حدود الانحراف بحيث تبقى ذات معنى وقليلة الضجيج. وما الصياغة الأدق للحدود في الواجهة حتى لا توهي بادعاء طبي. وما شكل تقرير المتابعة الأنفع لمقدم الرعاية دون أن يتحوّل إلى تشخيص. وكيف نصمّم فترة التعلّم لكل حالة.

انتهت الوثيقة. اقرأها داخل حدّ عدم الادعاء الطبي في أولها. تراجع كل ما يمسّ الاستخدام الطبي مع مستشار طبي قبل أي إطلاق.